

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE

CONCOURS DE RESIDANAT 2025

La Tuberculose Pulmonaire Commune

(Evaluation)

Pr Imen Gargouri

Pr Foued Bellazreg

QCM

1. La tuberculose est une maladie :
 - A- parasitaire
 - B- A transmission oro-fécale
 - C- Contagieuse
 - D- Endémique
 - E- Plus fréquente chez les femmes que chez les hommes
2. La tuberculose :
 - A- Son incidence augmente avec l'incidence de l'infection par le VIH
 - B- Est plus élevée dans les pays développés
 - C- Son incidence était de 10,7 millions nouveaux cas dans le monde en 2023
 - D- Sa mortalité est en baisse en 2023 par rapport à 2019
 - E- A augmenté pour la localisation ganglionnaire ces dernières années En Tunisie
3. *Mycobacterium tuberculosis hominis* est :
 - A- Une bactérie strictement humaine
 - B- résistant à la chaleur
 - C- Un bacille acido-alcool-résistant
 - D- Difficile à cultiver en milieu anaérobie
 - E- Identifié en culture sur milieu de Lowenstein-Jensen en 24 à 48 heures
4. *Mycobacterium tuberculosis* est une bactérie :
 - A - Aéro-anaérobie
 - B – A développement strictement intracellulaire
 - C - Capable de résister à plusieurs antibiotiques
 - D - Colorable par la méthode de Gram
 - E - Colorable par la méthode de Ziehl- Neelsen
5. Le Bacille de Koch est :
 - A- un bacille incurvé de 10 à 15 millimètres de longueur
 - B- une bactérie aérobie stricte
 - C- Pourvu d'une capsule qui explique sa résistance à l'alcool et aux acides dilués
 - D- présent sur frottis sous forme de fins bâtonnets rouges isolés ou en amas
 - E- de croissance lente sur milieu enrichi
6. La transmission du BK :
 - A- Se fait par voie alimentaire
 - B- Est souvent par voie aérienne
 - C- Est favorisée par l'exposition prolongée à un sujet atteint de tuberculose pulmonaire ganglionnaire
 - D- Est fréquente quand la toux et l'expectoration chez le sujet source sont importantes
 - E- Diminue au bout de 3 semaines de traitement antituberculeux

7. Les facteurs favorisant la survenue d'une tuberculose pulmonaire :
- A- Des antécédents de primo-infection tuberculeuse
 - B- De mauvaises conditions socio-économiques
 - C- Les piqûres d'insectes
 - D- L'exposition aux fumées de bois
 - E- La silicose
8. Parmi les terrains suivants, citez ceux qui ont un risque accru de développer une tuberculose maladie :
- A- Un sujet infecté par le VIH
 - B- Une femme enceinte
 - C- Un épileptique
 - D- Un sujet atteint d'une insuffisance rénale chronique
 - E- Un patient sous interféron
9. Les manifestations de la tuberculose pulmonaire commune sont :
- A- Des sueurs nocturnes
 - B- Un amaigrissement
 - C- Un érythème noueux
 - D- Un pneumothorax
 - E- Une anorexie
10. Au cours de tuberculose pulmonaire évolutive chez l'adulte :
- A- L'hémoptysie est un signe constant
 - B- Cette hémoptysie est souvent de grande abondance
 - C- Le scanner thoracique est nécessaire au diagnostic
 - D- La présence de BAAR confirme le diagnostic
 - E- Le risque de contagiosité est important en cas de lésions cavitaires à la radiographie du thorax
11. Parmi ces prélèvements, le(s)quel(s) ; n'a aucun intérêt pour le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire :
- A -Tubage gastrique
 - B - Frottis de gorge
 - C- Expectoration spontanée
 - D- Expectoration sous fibroscopie
 - E- Lavage bronchique
12. Une tuberculose pulmonaire est confirmée par :
- A- La mise en évidence de BAAR à l'examen direct
 - B- Une IDR à la tuberculine positive
 - C- Un amaigrissement important chez un sujet jeune
 - D- L'association d'asthénie, d'anorexie et de sueurs profuses nocturnes
 - E- La présence d'une image de caverne sur la radiographie de thorax

13. La tuberculose pulmonaire commune peut se révéler par :
- A- des crâchats hémoptoeiques
 - B- Un pyopneumothorax traduisant la rupture d'une caverne tuberculeuse dans la plèvre
 - C- Une vomique salée
 - D- Un amaigrissement sur plusieurs semaines
 - E- Une kérato-conjonctivite
14. Une tuberculose pulmonaire cavitaire est révélée par :
- A- Une hémoptysie
 - B- un hippocratisme digital
 - C- Une toux rebelle aux anti-tussifs
 - D- Une pleurésie transudative
 - E- Un pyopneumothorax
15. Les images radiologiques caractéristiques d'une tuberculose pulmonaire active sont :
- A- l'aspect d'arbre en bourgeon au scanner
 - B- Des infiltrats
 - C- Des excavations
 - D- Des calcifications
 - E- Des lyses costales
16. La tuberculose pulmonaire commune est suspectée radiologiquement par :
- A- Des nodules au niveau des sommets
 - B- Des infiltrats labiles et migrants
 - C- Des opacités spiculés
 - D- Un « chancre d'inoculation » qui a tendance à se calcifier
 - E- De volumineuses adénopathies médiastinales et compressives
17. Les complications de la tuberculose pulmonaire sont :
- A- Des DDB bilatérales kystiques aux 2 poumons
 - B- Une aspergillose broncho-pulmonaire allergique
 - C- Une cavité résiduelle
 - D- Des séquelles fibreuses rétractiles
 - E- Une insuffisance respiratoire restrictive
18. L'association diabète - tuberculose pulmonaire commune (TPC) est caractérisée par :
- A- Un retard de négativation des bacilloscopies
 - B- Une toxicité hépatique fréquente
 - C- La fréquence de l'atteinte ganglionnaire
 - D- Des rechutes fréquentes
 - E- La fréquence des comas acido-cétosiques

19. L'apparition de la résistance du BK est favorisée par :
- A- Une irrégularité du traitement
 - B- La bilatéralité des lésions
 - C- Une association insuffisante des anti-tuberculeux
 - D- Une insuffisance rénale
 - E- Une pleurésie associée
20. Le diagnostic différentiel radiologique de la TPC se pose avec :
- A- Un aspergillome pulmonaire
 - B- Un kyste hydatique rompu
 - C- Un cancer bronchique nécrosé
 - D- Une pleurésie enkystée
 - E- Une lymphangite carcinomateuse
21. La rifampicine :
- A- Est un antituberculeux majeur
 - B- Possède une action anti-staphylococcique
 - C- Diminue l'effet des anti-vitamines K
 - D- Engendre une hématurie
 - E- Sa posologie chez l'adulte est de 5 mg/kg/j
22. L'isoniazide (INH) :
- A- Est un antituberculeux de deuxième ligne
 - B- Est néphrotoxique
 - C- Possède une toxicité hépatique
 - D- Sa posologie chez l'adulte est de 10 mg/kg/j
 - E- Est prescrit au cours de la chimioprophylaxie antituberculeuse
23. L'éthambutol :
- A- Est un antituberculeux majeur
 - B- Est prescrit à la dose de 10 mg/kg/j
 - C- Altère la vision des couleurs
 - D- Peut être utilisé chez la femme enceinte
 - E- Est un antibiotique bactériostatique
24. Les règles du traitement antituberculeux comportent :
- A- Une déclaration obligatoire
 - B- Un bilan d'hémostase
 - C- Un traitement quadruple quotidien durant six mois
 - D- Une prise à jeun des comprimés
 - E- Un dosage sérique systématique de la pyrazinamide

25. Selon le schéma thérapeutique du plan national de lutte antituberculeuse, la 2^{ème} phase du traitement d'une tuberculose pulmonaire comporte la bithérapie suivante :
- A- INH-Pyrazinamide
 - B- Rifampicine-Pyrazinamide
 - C- Rifampicine-INH**
 - D- INH-Streptomycine
 - E- Rifampicine-Streptomycine
26. Les règles du traitement d'une tuberculose pulmonaire bacillifère sont :
- A- Une déclaration facultative aux autorités sanitaires compétentes
 - B- Une prise unique des médicaments**
 - C- La prise des médicaments le matin au petit déjeuner comportant du lait pasteurisé
 - D- L'isolement du patient en milieu spécialisé**
 - E- Des fenêtres thérapeutiques (arrêts de 2-3 semaines) pour prévenir la toxicité des médicaments
27. Les éléments de surveillance du traitement d'une tuberculose pulmonaire commune sont :
- A- La température**
 - B- Le poids**
 - C- La bacilloscopie journalière
 - D- L'échographie thoracique
 - E- Le dosage des transaminases**
 - F- La sérologie VIH
28. Les éléments de surveillance d'un cas de tuberculose pulmonaire sous traitement sont :
- A- Radiographie des sinus
 - B- Echographie thoracique
 - C- Dosage des enzymes hépatiques**
 - D- Recherche de BK dans les crachats**
 - E- IDR à la tuberculine
29. Le BCG est :
- A- Est un vaccin vivant non virulent**
 - B- Confère une cicatrice durable**
 - C- Possibilité de développement d'effets secondaire locaux**
 - D- Protège contre la tuberculose maladie à 80%
 - E- Protège contre la miliaire tuberculeuse**
30. La vaccination par le BCG :
- A. Procure une immunité définitive contre la tuberculose
 - B. Est obligatoire à la naissance et chez la femme enceinte
 - C. Doit être renouvelée chaque année
 - D. Est contre-indiquée en cas de déficit immunitaire**
 - E. Protège contre les formes graves de tuberculose**

Cas Clinique 1 QCM

Mr F.R âgé de 45 ans, travaille dans un centre d'appel, père de deux garçons, tabagique 50 PA, consulte pour toux traînante ramenant des crachats striés de sang associée à un amaigrissement non chiffré et une fièvre et des sueurs nocturnes le tout évoluant depuis 1 mois.

- L'examen physique était normal en dehors d'une pâleur conjonctivale.
- La radiographie du thorax avait montré des opacités nodulaires et excavées au niveau de l'apex droit et en axillaire gauche.
- Le diagnostic de tuberculose pulmonaire commune était fortement suspecté.

31. Ce diagnostic repose sur :

- A- une IDR à la tuberculine fortement positive
- B- la positivité des recherches de BAAR à l'examen direct des expectorations
- C- la mise en évidence de condensations alvéolaires, de nodules centro-lobulaires et de cavités sur le scanner thoracique
- D- la présence d'une alvéolite lymphocytaire sur le lavage bronchiolo-alvéolaire
- E- la présence de granulome dans la biopsie bronchique

32. Une fois le diagnostic de tuberculose pulmonaire commune confirmé, le bilan pré-thérapeutique doit comporter chez ce patient :

- A- un bilan hépatique
- B- un dosage de l'uricémie
- C- une échographie rénale
- D- une audiométrie
- E- une ponction lombaire

33. Le traitement antituberculeux dans sa phase d'attaque doit comporter :

- A- la rifampicine
- B- la pyrazinamide
- C- la streptomycine
- D- l'ofloxacine
- E- l'isoniazide

34. L'enquête de dépistage :

- A- est Obligatoire pour l'entourage familial
- B- ne concernera que ses collègues proches pour l'entourage professionnel
- C- se basera sur un interrogatoire et une IDR
- D- se limitera à un cliché radiologique
- E - doit être déclenchée dès la confirmation du diagnostic.

CAS CLINIQUE 2

Un patient âgé de 46 ans, tabagique à 12PA, ouvrier, père de 2 enfants âgés respectivement de 4 et 10 ans, sans antécédents pathologiques a été hospitalisé pour une toux persistante avec altération de l'état général. L'examen physique trouve une fièvre à 38,7°C, un syndrome pleurétique droit et des adénopathies cervicales bilatérales. La radiographie du thorax a montré des opacités micronodulaires bi-apicales associées à des excavations et une opacité dense homogène de tonalité hydrique basale droite comblant le cul de sac droit et efface la coupole diaphragmatique droite. Le diagnostic de tuberculose pulmonaire commune a été suspecté. Les recherches de BK dans les crachats sont négatives.

QCM n°1 :

Quel (s) autre (s) examens complémentaires peut-on demander pour confirmer le diagnostic :

- A. Une intradermoréaction à la tuberculine
- B. Une biopsie d'une adénopathie cervicale
- C. Les tests IGRAs
- D. Une fibroscopie bronchique et lavage broncho-alvéolaire
- E. Une biopsie pleurale

QCM n°2 :

Le diagnostic de tuberculose pulmonaire est enfin confirmé, Le bilan pré-thérapeutique est normal. La patiente a été mise sous HRZE : 3 cp/j (poids : 52 Kg). Une semaine après le début du traitement, le patient a présenté un prurit.

Quelle sera la conduite à tenir :

- A. Associer un anti-histaminique
- B. Arrêt immédiat du traitement anti-tuberculeux
- C. Surveillance clinique
- D. Arrêter la Rifampicine
- E. Substituer par HR

QCM n°3 :

Quelle sera votre conduite à tenir vis-à-vis des enfants ?

- A. Aucune conduite
- B. Chimio-prophylaxie systématique pour les 2 enfants
- C. Un dépistage à la recherche de signes évocateurs de la tuberculose maladie
- D. Les tests IGRAs
- E. HRZ en fonction du poids

La petite fille âgée de 10 ans qui avait été vaccinée par le B.C.G à la naissance et qui avait eu à un an un contrôle tuberculinique négatif, avait cette fois, une réaction cutanée à la tuberculine phlycténulaire. Quelle est votre attitude vis-a-vis d'elle?

QCM n°4 :

- A. Vous refaites un contrôle des tests cutanés dans 3 mois
- B. Vous ne faites rien car elle a été vaccinée par le B.C.G
- C. Vous entreprenez une chimiothérapie antituberculeuse
- D. Vous pratiquez un examen clinique et une radiothérapie du thorax
- E. Vous faites désinfecter le logement par les services sanitaires